ANED / FAND

Plan Nacional Estratégico de Impacto Social, Transformación Laboral y Accesibilidad Digital

Octubre 2026

1. Marco Conceptual, Filosofía y Activismo en Primera Persona

El núcleo fundacional de esta organización nacional parte de una realidad invisible pero profundamente transformadora: el **diagnóstico tardío en la edad adulta del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y su solapamiento dentro del fenotipo autista, una condición combinada clínicamente conocida en las comunidades de apoyo como perfil AuDHD**. El descubrimiento de la neurodivergencia en la adultez suele generar en el individuo un proceso complejo de reestructuración vital, duelo por el tiempo pasado sin respuestas, e introspección profunda. Tras años o décadas realizando un sobreesfuerzo brutal inconsciente de enmascaramiento social (*masking*) para intentar encajar en estructuras y dinámicas diseñadas exclusivamente para mentes neurotípicas, estas personas sufren índices alarmantes de agotamiento cognitivo crónico (*burnout* autista) y comorbilidades severas de salud mental derivadas de la más absoluta falta de apoyos tempranos.

Por ello, la asociación se constituye bajo el principio inquebrantable del **activismo en primera persona**. No se plantea como una entidad paternalista gestionada de forma externa, sino como un vehículo técnico y político dirigido por los propios profesionales y adultos neurodivergentes. Vuestro equipo inicial —compuesto por el Director de Visión y Estrategia junto a dos psicólogas colegiadas y un técnico especialista en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), todos ellos neurodivergentes— confiere al proyecto una legitimidad, autenticidad y autoridad científica sin precedentes en el país. El objetivo no es "curar" ni adiestrar a las personas para que disimulen sus rasgos, sino defender un enfoque **neuroafirmativo**: validar las diferentes formas de procesamiento cognitivo, visibilizar las barreras reales que impone un entorno hostil y aportar herramientas institucionales, técnicas y tecnológicas para que el día a día sea sostenible y justo.

2. Detección Temprana en el Ámbito Educativo y el Factor Hereditario

El sistema educativo sufre una carencia estructural crítica: los docentes y equipos pedagógicos no reciben formación específica ni actualizada durante sus etapas universitarias para identificar el amplio espectro de la neurodiversidad. Esto provoca que el sistema solo detecte al alumno que muestra una hiperactividad física disruptiva en el aula, dejando en la marginalidad y la incomprensión a perfiles sutiles pero igualmente vulnerables. La asociación intervendrá en los claustros escolares y en las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) bajo las siguientes directrices detalladas:

A. El TDAH Inatento y el Fenotipo Autista Invisible

Se enseñará a los equipos docentes a identificar señales de alerta específicas que habitualmente pasan desapercibidas en las aulas:

- **El TDAH Inatento (con especial incidencia en niñas):** Alumnos que muestran una conducta pasiva, descrita comúnmente como "estar en las nubes" o mantener la mirada perdida. No causan disrupciones conductuales en clase, pero su cerebro procesa mil estímulos de forma simultánea, lo que fragmenta su atención. Presentan una inconsistencia profunda: pueden realizar un examen brillante si el tema activa su motivación intrínseca (hiperfoco), e interrumpir por completo su rendimiento al día siguiente. Sufren fallos severos en las funciones ejecutivas: pierden el material escolar, olvidan la entrega de deberes y se bloquean por completo ante la planificación de tareas extensas.
- **El Fenotipo Autista Camuflado:** Alumnos con una inteligencia media o superior que realizan una mímesis social obsesiva para imitar las conductas de sus iguales. La señal de alerta fundamental es el **agotamiento post-escolar**: niños que se comportan de forma "perfecta" en el colegio pero que, al cruzar la puerta de su hogar, sufren colapsos sensoriales, crisis de llanto o rabietas debido a la saturación acumulada durante el día. Asimismo, se formará a los docentes para identificar su sentido extremo de la justicia, la literalidad ante comentarios irónicos y la canalización de su energía hacia intereses profundos u obsesiones temáticas estructuradas (monotemas).
- **El perfil combinado (AuDHD):** Se instruirá sobre cómo la hiperactividad del TDAH puede camuflar la necesidad estricta de rutina del autismo, o cómo la rigidez autista puede frenar la impulsividad del TDAH, generando un perfil intermitente sumamente complejo que confunde a los psicopedagogos tradicionales si no disponen de esta formación neuroafirmativa.

B. El Factor Hereditario y el "Taller Espejo"

Dado que el TDAH y el autismo cuentan con un índice de heredabilidad biológica sumamente elevado, el diagnóstico de un niño es, casi siempre, la llave para el descubrimiento de sus progenitores. La asociación implementará el **"Taller Espejo"**: formaciones comunitarias destinadas a padres y madres donde, al explicar de forma didáctica las señales de alerta de la infancia, se aportarán los parámetros para que los adultos identifiquen esos mismos patrones en sus propias historias vitales. Esto resolverá dinámicas de frustración familiar y abrirá el camino hacia el diagnóstico tardío y la sanación de los adultos del hogar.

C. Importación del Modelo de Finlandia y Nueva Zelanda

Se promoverá de forma institucional el lema internacional **"Apoyo Primero, Etiqueta Después"**. Inspirado en los modelos de éxito de Finlandia y Nueva Zelanda que aplican el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL), se enseñará a los profesores que no deben esperar a que una familia consiga un dictamen o diagnóstico oficial en papel (trámite que en la sanidad pública puede demorarse años) para empezar a realizar adaptaciones en el aula. Si un docente identifica las luces de alarma de la inatención o la saturación, se le dotará de herramientas pedagógicas inmediatas: fraccionar las instrucciones, implementar descansos cerebrales (brain breaks), usar agendas visuales y flexibilizar los formatos de evaluación.

3. Concienciación Social y Transformación del Entorno Urbano

El enfoque estratégico de la asociación se aleja por completo del modelo médico tradicional que sitúa el "defecto" de forma exclusiva dentro del individuo. Siguiendo las corrientes más avanzadas del modelo social de la discapacidad, se argumentará que las limitaciones de una persona neurodivergente se manifiestan de forma severa cuando esta se ve obligada a interactuar con un entorno físico y social hostil, rígido e hiperestimulante.

El Modelo de Horas Silenciosas (Inspirado en Australia)

Para trasladar la neuroinclusión al tejido urbano y comercial de los barrios de España, la asociación creará e impulsará el sello **"Comercio Neurodivergente Amigable"**. Basado en las iniciativas implementadas de forma ordinaria en los supermercados y grandes superficies de Australia, se formará y asesorará a los comerciantes locales

para que establezcan de forma semanal las **"Horas Sensoriales"**. Durante estas franjas horarias prefijadas, los establecimientos se comprometerán por protocolo a:

- Apagar por completo los hilos musicales, la radio y las pantallas de publicidad interactiva.
- Reducir la intensidad de las luminarias artificiales a la mitad o sustituirlas por iluminación cálida regulable.
- Desactivar o atenuar al mínimo volumen los pitidos estridentes de las cajas registradoras, básculas y escáneres.
- Cesar cualquier tarea de reposición de stock que genere ruidos de impacto o manipulación de palets.

Esta medida democratizará el acceso a las tareas cotidianas de la vida adulta, permitiendo a las personas con hipersensibilidad sensorial comprar con autonomía y dignidad, reduciendo la ansiedad y la sobrecarga cognitiva.

4. Democratización del Diagnóstico y Apoyo Social Mutuo

La comprensión de uno mismo y el acceso a la salud mental no pueden ser un privilegio determinado por el nivel de ingresos de una familia. En España, un proceso de diagnóstico privado y riguroso de TDAH o autismo adulto oscila habitualmente entre los 500€ y los 800€, una cifra totalmente inasumible para familias vulnerables, desempleados o trabajadores precarios. La red de sanidad pública, por su parte, sufre una saturación estructural crónica, y las listas de espera en salud mental pueden demorarse meses o años, provocando el agravamiento de las crisis.

A. Servicio de Cribado e Informe de Sospecha Fundada

La asociación dispondrá de un servicio técnico de pre-diagnóstico y cribado gratuito para colectivos desfavorecidos y centros educativos situados en zonas de exclusión. Mediante la aplicación de escalas psicométricas validadas científicamente, entrevistas clínicas preliminares de historia vital y análisis del desarrollo sensoriomotor realizados por las psicólogas colegiadas de la entidad, se emitirá un **Informe de Sospecha Fundada**. Este documento no sustituye al dictamen psiquiátrico oficial, pero opera como una herramienta de presión legal y clínica ante la atención primaria para que los médicos de cabecera deriven de forma prioritaria e inapelable al paciente a las redes de salud mental del sistema público (CSMIJ para menores y CSMA para adultos), rompiendo el bloqueo burocrático.

B. Grupos de Ayuda Mutua (GAM) de Ámbito Nacional

Se estructurará una red nacional de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) específicos para perfiles adultos. Estas reuniones periódicas se configurarán como espacios horizontales, seguros y autogestionados. Su meta fundamental es ofrecer un refugio libre de juicios sociales donde esté permitido prescindir por completo de la máscara (*unmasking*). En ellos se validará el sufrimiento de los diagnósticos tardíos y se intercambiarán de forma colectiva estrategias reales sobre regulación emocional, manejo de la frustración ante la parálisis ejecutiva, organización doméstica adaptada y técnicas de gestión del tiempo.

5. Capacitación Laboral, Enfoque Vocacional y Transición Adulta

El tránsito desde la etapa escolar hacia el mercado de trabajo ordinario representa uno de los momentos de mayor vulnerabilidad, registrándose los índices más elevados de exclusión, desempleo crónico o desarrollo de patologías psiquiátricas graves. La asociación intervendrá en este ámbito mediante herramientas preventivas y de capacitación disruptivas:

A. Test de Perfil Clínico-Vocacional Adaptado

Se diseñará e implementará un test de orientación exclusivo para jóvenes y adultos que evaluará dos dimensiones críticas que los test de orientación tradicionales ignoran por completo:

- **El Vector de Motivación Intrínseca e Hiperfoco:** Las mentes TDAH y autistas dependen de estímulos motivacionales directos para activar la segregación de dopamina. Cuando un puesto de trabajo o área de conocimiento activa su interés profundo (monotema), son capaces de entrar en un estado de hiperfoco cognitivo, logrando niveles de productividad, minuciosidad, originalidad y resolución de problemas excepcionales. El test mapeará estas áreas para dirigir los estudios superiores hacia sectores de alta compatibilidad (desarrollo de software, diseño analítico, investigación avanzada, gestión de datos complejos, etc.).
- **El Vector de Tolerancia Ambiental y Regulación Sensoriomotora:** Evaluará de forma realista la resistencia física y sensorial del individuo ante entornos laborales estándar. Analizará parámetros como la *tolerancia estática* (capacidad para permanecer sentado inmóvil en una silla en trabajos de oficina tradicionales sin sufrir desregulación psicomotriz), la *saturación sensorial* ante estímulos lumínicos u oficinas abiertas (open spaces), y la *necesidad kinestésica* (hiperactividad física del

TDAH) que requiera puestos dinámicos con flexibilidad de deambulación. Con este informe, se guiará al usuario para saber qué entornos potenciarán su salud y cuáles le causarán un burnout asegurado (como la atención telefónica masiva e imprevista en entornos ruidosos).

B. Redacción de Currículum Neuroafirmativo

Se impartirán talleres prácticos para aprender a redactar historiales profesionales que pongan en valor las competencias cognitivas de la neurodivergencia (pensamiento lateral, minuciosidad extrema, honestidad radical, memoria de detalles). Asimismo, se aportarán estrategias técnicas para justificar y normalizar la **inconsistencia en el expediente laboral** (periodos vacíos de meses o años), explicando de manera asertiva que corresponden a fases de reestructuración vital o crisis previas a la obtención del diagnóstico tardío, protegiendo la autoestima del candidato durante los procesos de selección.

C. Laboratorio de Simulación de Entrevistas (Role-Playing)

Se realizarán dinámicas de simulación real donde los profesionales de la asociación recrearán entrevistas de selección estándar para entrenar de forma práctica al usuario en:

- **Manejo de la literalidad y la ambigüedad:** Descomponer e interpretar qué busca realmente un reclutador corporativo cuando formula preguntas abstractas y ambiguas (como por ejemplo, *"¿Dónde te ves en cinco años?"* o *"Háblame de un defecto tuyo"*).
- **Solicitud asertiva de adaptaciones (Inspirado en el Reino Unido):** Enseñar al candidato a solicitar alternativas amparadas por la ley en los procesos de selección, tales como requerir las preguntas de la entrevista con 15 minutos de antelación para mitigar el bloqueo del habla por imprevistos, o solicitar pruebas técnicas de ejecución directa en lugar de evaluaciones sociales abstractas de manera homóloga al programa británico *Access to Work*.
- **Uso de herramientas de regulación:** Normalizar y validar que el candidato pueda emplear elementos discretos de estimulación sensorial (***fidgets***) o solicitar pausas breves de ventilación cognitiva si la presión de la sala satura su capacidad de respuesta.

D. Consultoría y Auditorías Sensoriales para Empresas (Inspirado en EE.UU.)

Inspirado en las metodologías de entidades estadounidenses como *Understood.org*, la asociación ofrecerá servicios de consultoría homologados a los departamentos de Recursos Humanos y comités de Riesgos Laborales de empresas privadas. Se realizarán Auditorías Sensoriales Express en los centros de trabajo. La asociación evaluará las oficinas y emitirá un informe técnico con modificaciones de bajo coste para retener el talento neurodivergente: sustitución de luces de descarga fluorescente por iluminación LED cálida regulable, colocación de pantallas acústicas divisorias, implantación de salas de bajo estímulo (*quiet rooms*) para la regulación de crisis y la normalización del uso de auriculares con cancelación de ruido activa en el puesto de trabajo.

E. Programa de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) Psicosocial

Alineándonos con las herramientas preventivas de salud mental y neurodiversidad lanzadas por las confederaciones empresariales oficiales en España (como la patronal CEOE), la asociación creará e impartirá dos líneas de capacitación técnica:

1. **Escuela de Autocuidado y PRL para el Trabajador: Formación dirigida a dotar al empleado de estrategias de autoprotección psicológica (gestión de la fatiga cognitiva, organización del tiempo adaptada al TDAH rompiendo sistemas rígidos tradicionales, alternancia de tareas para evitar la parálisis por análisis y manejo del masking para prevenir bajas laborales).**
2. **Capacitación en Adaptaciones para Mandos Intermedios: Formar a los líderes en protocolos de comunicación clara, explícita y estructurada por escrito, eliminando la ambigüedad, y adiestrar a los técnicos de prevención en la implantación del teletrabajo como una medida primordial de salud laboral y conciliación cognitiva.**

6. Modelo Económico de Redistribución e Hibridación Social

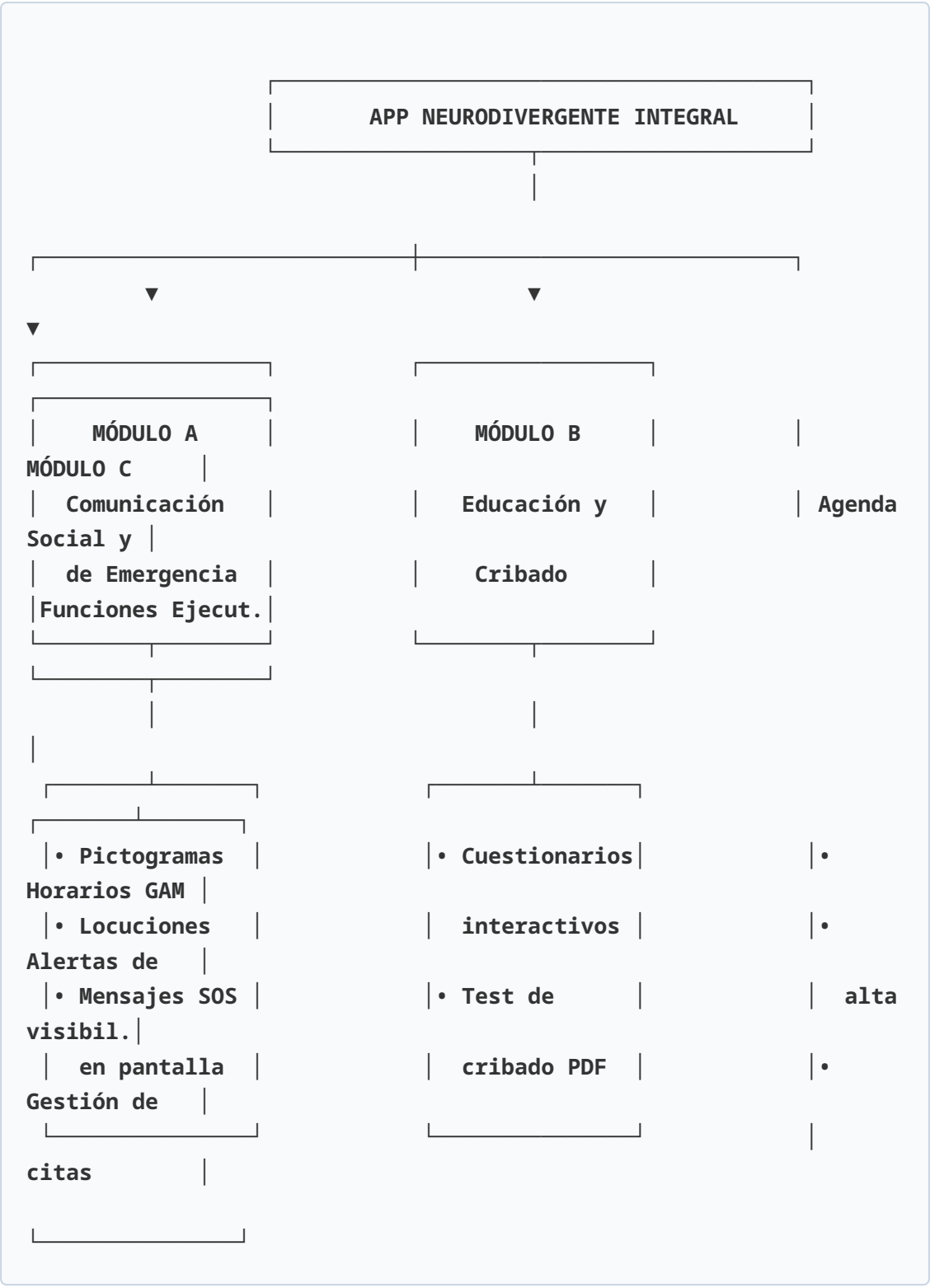
La asociación operará legalmente bajo un modelo de empresa social mixta, perfectamente amparado por el ordenamiento jurídico de las entidades sin ánimo de lucro en España. Los estatutos de la organización blindarán explícitamente la capacidad de realizar actividades económicas integradas

orientadas al cumplimiento de sus fines (servicios de consultoría, auditoría psicosocial y formación laboral corporativa a empresas privadas).

De este modo, se genera un círculo perfecto de redistribución solidaria: la asociación emitirá facturas con IVA a las empresas medianas y grandes por las Auditorías Sensoriales y los cursos de PRL de pago. El 100% de los beneficios económicos obtenidos de estas contrataciones privadas corporativas se reinvertirá de forma automática en los fines sociales de la entidad. Estos fondos privados se destinarán a financiar los materiales didácticos gratuitos de los colegios públicos, sufragar el desarrollo de la App y dotar a la asociación de un Fondo de Becas de Diagnóstico y Apoyo Legal para personas sin recursos. Asimismo, estos ingresos propios resolverán la exigencia legal de cofinanciación de las subvenciones públicas, aportando de forma autónoma el 10% o 20% del coste de los proyectos que las administraciones obligan a aportar a las entidades sin recurrir a deudas.

7. Arquitectura de la Plataforma Digital (La App Integral)

Toda la infraestructura operativa, de cribado y soporte logístico a nivel nacional se centralizará en una única aplicación móvil avanzada de alta accesibilidad cognitiva, estructurada en tres módulos funcionales:



- **Módulo A: Sistema de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) de Emergencia. Diseñado para personas autistas adultas independientes y verbales que, ante crisis de ansiedad graves, accidentes o colapsos por sobrecarga sensorial en la vía pública o el entorno de trabajo, sufren episodios temporales de mutismo selectivo o bloqueos totales del habla. Mediante una interfaz táctil simplificada, el usuario podrá activar pictogramas**

claros y locuciones pregrabadas de alta fidelidad, o mostrar textos explicativos detallados a pantalla completa para comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia, policías o viandantes (ejemplo: *"Estoy sufriendo un bloqueo del habla por saturación, entiendo lo que me dice pero no puedo emitir voz, por favor indíqueme una zona tranquila sin ruido"*).

- **Módulo B: Herramienta Gamificada de Autoevaluación Pedagógica y Cribado.** Albergará los cuestionarios interactivos de asimilación de conceptos para que profesores y familias derriben sesgos y falsos mitos sobre el TDAH/Autismo desde su móvil. Asimismo, integrará el motor digital del Test Clínico-Vocacional y los pre-test de sospecha basados en escalas psicométricas oficiales, exportando de forma automática los informes estructurados en PDF listos para descargar y presentar ante la sanidad pública.
- **Módulo C: Agenda de Soporte a las Funciones Ejecutivas.** Diseñado específicamente para mitigar los efectos de la ceguera temporal, los déficits de memoria de trabajo y la tendencia a la distracción propios del perfil TDAH. Funcionará como el centro de control logístico nacional de la asociación, informando mediante alertas push automatizadas de alta visibilidad visual sobre los días, horas y formatos (presenciales u online) de los Grupos de Ayuda Mutua, talleres de currículum y asambleas, asegurando la adherencia de los usuarios a las redes de apoyo sin sufrir bloqueos organizativos.

8. Estrategia Internacional de Presión Legal y Recogida de Firmas (ICE)

Para lograr que las administraciones públicas eliminen las trabas burocráticas actuales que impiden el reconocimiento directo de la neurodivergencia como una situación de discapacidad, la asociación no recurrirá a campañas comerciales superficiales. Se activará un mecanismo de presión legal internacional de máxima jerarquía jurídica: la **Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)**, un canal oficial amparado por el Tratado de Lisboa de la Unión Europea.

La asociación redactará y registrará ante la Comisión Europea una petición oficial para exigir una Directiva de Armonización Europea de la Neurodiscapacidad. Apoyándonos en las redes internacionales y transversales de derechos de la discapacidad como la **red europea ENIL (European Network on Independent Living)** y las directrices de la federación **Autism-Europe** en Bruselas, la campaña iniciará una movilización coordinada para conseguir **1

millón de firmas** de ciudadanos procedentes de al menos 7 estados miembros de la UE. Al alcanzar este hito legal, la Comisión Europea estará obligada por ley a recibir formalmente a la dirección de la asociación, abrir un debate parlamentario y emitir un dictamen legislativo. El argumento central ante Bruselas será que los criterios de valoración actuales vulneran el Acta Europea de Accesibilidad y discriminan de forma sistemática a los adultos con diagnósticos tardíos inteligentes y verbales, ignorando el coste destructivo del masking y la disfunción ejecutiva. Una Directiva de la UE obligaría a España a reformar de inmediato sus tribunales médicos bajo la amenaza de sanciones financieras internacionales directas al Estado.

9. Régimen Sancionador Español y Retorno Sanitario Institucional

La asociación operará como un escudo de defensa jurídica para el colectivo a nivel nacional, utilizando la legislación punitiva vigente en España para exigir el cumplimiento de las adaptaciones laborales. Una vez que la asociación asista al usuario neurodivergente para obtener el reconocimiento oficial de su situación de discapacidad (grado igual o superior al 33%), las empresas privadas quedan obligadas por ley a realizar los ajustes razonables requeridos por sus perfiles. Si una empresa se niega a implementar las adaptaciones sensoriales u horarias justificadas por los profesionales, la asociación tramitará denuncias formales ante la **Inspección de Trabajo**, amparándose en la **Ley General de Discapacidad (LGD)** y en la **Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS)**. Las sanciones económicas a las que se enfrentan las corporaciones son severas y se dividen en:

- Infracciones Leves: Multas de 301 € a 30.000 €.
- Infracciones Graves (Negativa explícita a realizar adaptaciones razonables solicitadas): Multas de 30.001 € a 90.000 €.
- Infracciones Muy Graves (Discriminación directa, acoso laboral o represalias): Multas de 90.001 € hasta 1.000.000 €, sumado a la pérdida total de bonificaciones públicas y la prohibición absoluta de contratar con el Estado.

Este marco punitivo se presentará ante las administraciones públicas como un proyecto de altísimo retorno institucional y ahorro presupuestario. Formar a los

docentes hoy para detectar tempranamente e intervenir de forma neuroafirmativa mitiga de manera directa la aparición de depresiones mayores, trastornos de ansiedad severa, trastornos de la conducta alimentaria (TCA) inducidos por la desregulación emocional, e intentos de autolisis. Esto reducirá drásticamente la saturación de las urgencias psiquiátricas y de los centros de salud mental de adultos (CSMA) del sistema público de salud. Asimismo, incrementará la estabilidad del mercado de trabajo, reduciendo las elevadísimas tasas de desempleo del colectivo y minorando el gasto público masivo destinado al pago de subsidios y bajas médicas prolongadas por estrés o desgaste laboral.

10. Línea de Investigación Futura: Adicciones y Dopamina

(Este bloque queda registrado de forma formal en el tintero técnico del Plan Maestro de la entidad para ser desarrollado con total rigurosidad clínica y metodológica durante la segunda fase operativa de la asociación nacional).

Se estructurará un programa nacional de investigación y prevención enfocado en el profundo solapamiento existente entre las condiciones neurodivergentes y el desarrollo de conductas adictivas, tanto de carácter químico (sustancias) como conductual (uso compulsivo de pantallas, adicción a videojuegos, ludopatía digital o compras impulsivas). La investigación partirá de la base del déficit neurobiológico crónico de dopamina característico del perfil TDAH, que empuja al individuo a la búsqueda desadaptativa de estímulos inmediatos para regular su corteza prefrontal, así como de la utilización de sustancias o conductas de evasión por parte de los perfiles autistas como mecanismo de anestesia frente al dolor sensorial y el agotamiento del masking. La asociación luchará para que las redes públicas de atención a las adicciones incorporen protocolos de cribado neurodivergente obligatorios, evitando tratamientos estándar que ignoran la raíz del neurodesarrollo.

Este es un documento de planificación estratégica asociativa nacional. Para cualquier proceso formal de registro o solicitud de ayudas públicas, la documentación legal deberá ser presentada de conformidad con las guías técnicas del Ministerio del Interior y los órganos correspondientes. AI responses may include mistakes.